

奥美拉唑所致不良反应及与其他药物相互作用特点分析

邹检名¹ 黄 畅²

1. 广东省东莞市长安镇乌沙医院药剂科, 广东东莞 523858; 2. 湖南省湘潭市第四医院, 湖南湘潭 411206

[摘要] 目的 分析奥美拉唑所致不良反应及与其他药物相互作用的特点。方法 选择笔者所在医院 2011 年 3 月 ~ 2012 年 3 月 120 例消化性溃疡患者, 随机分为两组, 观察组 60 例患者给予奥美拉唑治疗, 对照组 60 例患者给予雷尼替丁, 对两组患者的不良反应进行观察。结果 主要的不良反应是腹泻、消化不良、头晕头痛、心动过速、白细胞减少。观察组共发生不良反应 8 例, 发生率为 13.33%; 对照组发生不良反应 10 例, 发生率为 16.67%; 观察组不良反应发生率略低于对照组, 但组间比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。结论 临床需重视奥美拉唑的不良反应及与其他药物的相互作用, 服药时要全面分析。

[关键词] 奥美拉唑; 不良反应; 相互作用

[中图分类号] R969.2

[文献标识码] B

[文章编号] 2095-0616 (2012) 16-69-02

奥美拉唑是临床常用抑制胃酸分泌药物, 其药理作用是作用于胃黏膜壁细胞以降低壁细胞中的 H^+-K^+-ATP 酶的活性^[1], 从而达到抑制胃酸分泌的目的。奥美拉唑在临床上主要用于胃、十二指肠溃疡反流性食管炎的治疗, 但随着使用频率的增加, 其不良反应也日益显现。本研究选择笔者所在医院 2011 年 3 月 ~ 2012 年 3 月 120 例消化性溃疡患者, 分别给予奥美拉唑与雷尼替丁治疗, 观察患者不良反应及与其他药物的相互作用特点, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取笔者所在医院 2011 年 3 月 ~ 2012 年 3 月 120 例消化性溃疡患者, 随机分为两组。观察组 60 例, 其中男 28 例, 女 32 例, 年龄 26 ~ 74 岁, 平均 (51.5 ± 25.5) 岁; 对照组 60 例, 其中男 29 例, 女 31 例, 年龄 25 ~ 73 岁, 平均 (50.5 ± 25.5) 岁。两组患者的年龄、性别、原发疾病等各方面比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

所有患者均经内镜确诊为胃及十二指肠溃疡, 所有患者在此 1 周前均未服用过其他抑酸及抗溃疡药物, 同时均获得患者知情同意, 排除严重肝、肾功能不全者。

1.3 治疗方法

1.3.1 观察组 本组 60 例患者均给予口服奥美拉唑(河北爱尔海泰制药有限公司, H20063168) 20 mg 治疗, 2 次/d, 疗程为 4 周, 治疗期间不服用其他药物, 以便于本研究。

1.3.2 对照组 本组 60 例患者均给予口服雷尼替丁(广东恒健制药有限公司, H44021173) 20 mg 治疗, 2 次/d, 疗程为 4 周, 治疗期间不服用其他药物。

1.4 观察指标

观察治疗期间患者不良反应。

1.5 统计学处理

数据采用 SPSS13.0 统计学处理, 计量资料用 $(\bar{x} \pm s)$ 的形式表示, 采用 t 检验, 计数资料采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

比较两组不良反应, 主要的不良反应是腹泻、消化不良、头晕头痛、心动过速、白细胞减少。观察组共发生不良反应 8 例, 发生率为 13.33%; 对照组发生不良反应 10 例, 发生率为 16.67%; 观察组不良反应发生率略低于对照组, 但组间比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 1。

3 讨论

作为新一代抑制胃酸药物, 奥美拉唑的不良反应主要是腹泻、消化不良、头晕头痛、心动过速、白细胞减少^[2]。本研究将患者单一服用奥美拉唑的不良反应与过去常用的抑制胃酸药物雷尼替丁相比较结果显示, 观察组共发生不良反应 8 例, 发生率为 13.33%; 对照组发生不良反应 10 例, 发生率为 16.67%; 观察组不良反应发生率略低于对照组, 但组间比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。结果提示奥美拉唑有与雷尼替丁相同的不良反应, 且反应较同类药物小。

胃酸抑制类药物之所以会出现上述不良反应, 笔者分析原因可能是服药期间可导致胃内 pH 发生改变, 因此, 可能出现一系列胃肠道反应^[3], 如消化不良、腹泻等。据相关文献报道, 长期服用抑酸药物, 可造成胃酸分泌减少, 从而为细菌的大量繁殖生长提供了可乘之机, 长期抑制胃酸, 嗜铬细胞增生可促进亚硝基化合物的合成, 甚至可能导致胃癌的发生。另有报道显示, 奥美拉唑还会对神经系统产生不良影响, 从观察组不良反应各类型显示, 出现 2 例头晕头痛, 发生率为 3.33%。奥美拉唑作用于循环系统上的不良反应表现为心动过速, 观察组 60 例患者中出现 1 例, 发生率为 1.67%。

表1 两组患者服药期间不良反应比较[n (%)]

组别	n	腹泻	消化不良	头晕头痛	心动过速	白细胞减少	发生率 (%)
观察组	60	2 (3.33)	1 (1.67)	2 (3.33)	1 (1.67)	2 (3.33)	13.33
对照组	60	2 (3.33)	2 (3.33)	3 (5.00)	1 (1.67)	2 (3.33)	16.67

(下转第 72 页)

3 讨论

小儿肺炎被 WHO 列为全球 3 种重要儿科疾病之一,在我国,发病率和致死率均居小儿疾病之首,严重危害儿童健康和生命。我国小儿肺炎多由细菌引起,以肺炎双球菌最为常见,其次是金黄葡萄球菌、溶血性链球菌、流感杆菌及大肠杆菌等,近年来,通过临床检测,支原体的致病率有上升趋势。在治疗上,多用抗生素,缺乏合理规范药物。

肺炎治疗的首要原则是杀死病原菌,肺炎是大环内酯类抗生素敏感型疾病,阿奇霉素是半合成红霉素衍生物,属于新一代大环内酯类抗生素,可在吞噬细胞内聚集,在吞噬细胞向炎症部位迁移过程中释放出来,在感染部位达到较高浓度,因此具备作用集中,局部药物浓度高,代谢缓慢,药性持久等优势。黄纯等^[4]报道其抗支原体肺炎效果优于红霉素,副作用也较红霉素少。

痰热清注射液是中药复方制剂,由金银花、连翘、黄芩、熊

胆粉、山羊角组成,具有清热解毒、宣肺化痰、化痰解痉、止咳平喘、抑菌和抗病毒等多重功效,此外,山羊角还具有显著的镇静和免疫调节作用。诸药联合作用,共同发挥效能,具备增强机体防御机能和调节免疫功能双重功效。

本研究显示,两者合用不仅疗程较短,疗效显著,而且可改善患者身体健康状况及抗生素引发的胃肠道反应,安全性高。

[参考文献]

- [1] 栗顺概. 小儿肺炎支原体肺炎的研究进展 [J]. 中国医药指南, 2012, 10(2): 70-71.
- [2] 胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学 [M]. 第 7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 1204-1205.
- [3] 李瑾. 痰热清联合阿奇霉素治疗小儿肺炎效果观察 [J]. 中国基层医药, 2011, 18(16): 2252-2253.
- [4] 黄纯, 陈朝霞, 刘柳明. 阿奇霉素联合痰热清治疗小儿肺炎支原体肺炎 71 例的疗效观察 [J]. 广西医学, 2010, 32(2): 188-190.

(收稿日期: 2012-05-14)

(上接第 69 页)

奥美拉唑与其他药物共用可能发生协同作用,临床常选择奥美拉唑与抗生素使用用于治疗幽门螺杆菌感染性溃疡,由于奥美拉唑的抑制胃酸作用,服用后会导致胃内 pH 值明显升高,每天 20 mg 奥美拉唑可以维持胃内 pH 在 6 ~ 8^[4],而抗菌药物中氨苄西林及酶化物只有在酸性环境下完全吸收,而当 pH 在 6 ~ 8 时,可致脂溶性降低,使非分子型药物增多,酯结构受到破坏,而四环素在 pH 6 ~ 8 的碱性环境下,将会变成难溶性游离四环素,使血液浓度下降,影响吸收,达不到治疗效果。因此,在选择抗生素时不宜选择上述抗生素。

奥美拉唑除了与抗生素具有协同作用外,还与华法林、地高辛、地西泮等发生相互作用,奥美拉唑可增强华法林的抗凝作用,而地高辛在低酸环境下,药效维持较短,同时服用将会严重影响治疗效果。服用奥美拉唑后,要使胃酸正常分泌,需要停药后 7 ~ 10 d,因此,在临床使用时应充分考虑这一问题,如需使

用地高辛治疗应在停用奥美拉唑 7 ~ 10 d 后,才能达到预期的效果。奥美拉唑可使受试者的地西泮清除率降低 20% 左右。奥美拉唑还与肝药酶代谢有关的药物发生协同作用,奥美拉唑对肝药酶 P450 有抑制作用。此外,硝苯地平、苯妥英钠、氨基比林等药物也受奥美拉唑的影响,在合用时应充分考虑,以确保治疗效果。

[参考文献]

- [1] 李明华, 肖真. 奥美拉唑不良反应及临床使用中注意的问题 [J]. 实用医技杂志, 2008, 15(33): 4783.
- [2] 张华冰, 倪庆芳. 奥美拉唑与其他药物的相互作用 [J]. 中国误诊学杂志, 2007, 7(5): 1154.
- [3] 邓秀娟, 谭宇军, 蒋慧倩. 奥美拉唑引起罕见不良反应可逆性精神错乱 1 例报道 [J]. 中国医药导报, 2010, 7(1): 133.
- [4] 李碧虹, 陈君远, 吴毅丹. 奥美拉唑 67 例不良反应分析 [J]. 中国现代药物应用, 2009, 3(24): 32-33.

(收稿日期: 2012-05-08)

(上接第 70 页)

不能够满足新生儿对于呼吸的要求^[2],此时就会出现呼吸急促等表现。该病在早产儿发病率较高,主要是与胎肺没有发育成熟有关。

对于新生儿,尤其是早产儿的肺泡并没有发育成熟,肺表面活性物质较少,肺毛细血管血流量较少,从而引起 β 肾上腺能受体的敏感性降低,导致呼吸中枢没有发育完全。因此,肺表面活性物质缺乏容易引起新生儿呼吸窘迫综合征,笔者主要探讨肺表面活性物质对新生儿呼吸窘迫综合征的治疗效果。

肺表面活性物质是一种磷脂蛋白的复合物,主要由 II 型肺泡上皮细胞产生,主要作用有:(1)对肺表面张力起到降低的作用,从而阻止肺泡萎缩,对肺泡内压力起到维持的作用^[3];(2)能够改善水肿,增加肺纤毛的顺应性,改善呼吸困难症状;(3)能够对肺泡容积进行维持,防止肺泡萎缩;(4)降低肺毛细血管的压力,增加肺通气量,增加肺泡内氧分压,减轻呼吸困难^[4];

(5)对肺泡上皮细胞具有保护作用;(6)降低肺毛细血管的表面张力,防止毛细血管发生痉挛。

本研究主要观察肺表面活性物质对于新生儿呼吸窘迫综合征的治疗效果,结果显示肺表面活性物质对于新生儿呼吸窘迫综合征的治疗效果较好,能够提高治疗有效率,改善患儿的肺功能,具有很好的临床应用价值。

[参考文献]

- [1] 王留彬, 陈菲, 刘宇. 肺表面活性物质对呼吸窘迫综合征高危患儿的预防作用 [J]. 临床肺科杂志, 2010, 15(10): 1470.
- [2] 康宏, 拉热. 固尔苏联合机械通气治疗新生儿呼吸窘迫综合征的疗效观察 [J]. 临床荟萃, 2010, 25(18): 1630-1631.
- [3] 陈超. 肺表面活性物质在新生儿肺部疾病中的应用进展 [J]. 中国实用儿科杂志, 2003, 18(11): 652.
- [4] 郭德康. 肺泡表面活性物质预防新生儿呼吸窘迫综合征的疗效 [J]. 中国当代医药, 2011, 18(14): 56-57.

(收稿日期: 2012-05-08)